

KARTA PACJENTA

Ostre zapalenie trzustki - przykład fikcyjnej dokumentacji

UWAGA: to jest fikcyjny wzór edukacyjny. Nie jest prawdziwą dokumentacją medyczną ani zaleceniem leczenia.

Placówka	Oddział	Nr karty	Data/godzina przyjęcia
Szpital Miejski - wzór	SOR / Chirurgia	FIK-2026-001	13.06.2026, 10:35

1. Dane pacjenta

Imię i nazwisko	Jan Kowalski	PESEL / ID	FIKCYJNY
Wiek	48 lat	Płeć	Mężczyzna
Kontakt alarmowy	Anna Kowalska, tel. 000 000 000	Alergie	Nie zgłasza / brak danych
Tryb przyjęcia	Nagły - ból brzucha	Zgoda RODO	Nie dotyczy - wzór

2. Rozpoznanie wstępne

Rozpoznanie	Ostre zapalenie trzustki, prawdopodobnie łagodne/umiarkowane - do dalszej obserwacji
Kod ICD-10	K85 - Ostre zapalenie trzustki
Główne powody podejrzenia	Silny ból w nadbrzuszu promieniujący do pleców, nudności/wymioty, podwyższona lipaza/amylaza

3. Wywiad i objawy przy przyjęciu

Objaw / element wywiadu	Opis
Ból	Silny, stały ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców; początek około 8 godzin przed przyjęciem.
Nudności/wymioty	Obecne; pacjent zgłasza 3 epizody wymiotów.
Gorączka/dreszcze	Stan podgorączkowy, bez dreszczy.
Alkohol / dieta	Pacjent zgłasza ciężkostrawny posiłek poprzedniego dnia; alkohol: do weryfikacji.
Choroby przebyte	Nadciśnienie tętnicze w wywiadzie; kamica żółciowa do wykluczenia.

4. Badanie przedmiotowe i parametry życiowe

Parametr	Wartość	Uwagi
Ciśnienie tętnicze	145/90 mmHg	monitorować
Tętno	104/min	tachykardia
Temperatura	37,8 °C	stan podgorączkowy
SpO2	98%	powietrze atmosferyczne
Brzuch	tkliwy w nadbrzuszu, bez jawnych objawów otrzewnowych	kontrola seryjna
Stan ogólny	średni, pacjent przytomny, logiczny	GCS 15

5. Badania laboratoryjne - przykładowe wyniki

Badanie	Wynik	Zakres/ref.	Komentarz
Lipaza	1 250 U/l	< 60 U/l	znacznie podwyższona
Amylaza	680 U/l	< 100 U/l	podwyższona
CRP	62 mg/l	< 5 mg/l	stan zapalny
Leukocyty	14,2 G/l	4,0-10,0 G/l	leukocytoza
Kreatynina	1,1 mg/dl	0,7-1,3 mg/dl	w normie
Glukoza	168 mg/dl	70-99 mg/dl	podwyższona
Bilirubina całk.	1,6 mg/dl	< 1,2 mg/dl	lekko podwyższona
ALT/AST	78/65 U/l	< 40 U/l	do korelacji z drogami żółciowymi

6. Badania obrazowe

Badanie	Opis / wynik
USG jamy brzusznej	Trzustka słabo widoczna przez gazy jelitowe. Pęcherzyk żółciowy: możliwe drobne złogi - do potwierdzenia. Drogi żółciowe bez jednoznacznego poszerzenia.
TK jamy brzusznej	Do rozważenia przy pogorszeniu stanu, niejasnym rozpoznaniu lub podejrzeniu powikłań.

7. Ocena ciężkości i ryzyka

Element	Ocena
Wstępna ciężkość	Brak cech wstrząsu przy przyjęciu; wymaga obserwacji i kontroli parametrów.
Ryzyko odwodnienia	Podwyższone ze względu na wymioty i ograniczone przyjmowanie płynów.
Powikłania do monitorowania	Niewydolność narządowa, martwica trzustki, zakażenie, zaburzenia elektrolitowe, hiperglikemia.

8. Postępowanie zalecone w oddziale - przykład

- ☒ Przyjęcie do obserwacji / oddziału chirurgicznego lub internistycznego
- ☒ Dieta ścisła początkowo, następnie żywienie według tolerancji i decyzji lekarza
- ☒ Intensywne nawodnienie dożylne z kontrolą bilansu płynów
- ☒ Leczenie przeciwbólowe i przeciwwymiotne według zleceń lekarskich
- ☒ Kontrola morfologii, CRP, jonogramu, kreatyniny, glikemii, enzymów trzustkowych
- ☒ Monitorowanie tętna, ciśnienia, temperatury, diurezy i bólu
- ☒ Konsultacja chirurgiczna/gastroenterologiczna; diagnostyka przyczyny, w tym kamica żółciowa
- ☐ Antybiotyk tylko przy wskazaniach klinicznych - nie rutynowo w niepowikłanym przebiegu

9. Zlecenia kontrolne

Czas	Zlecenie
0-6 h	Kontrola bólu, parametrów życiowych, bilansu płynów, diurezy; ponowna ocena brzucha.
6-12 h	Powtórzyć morfologię, CRP/jonogram/kreatyninę/glikemię zgodnie ze stanem pacjenta.
24 h	Ocena tolerancji żywienia, trendu zapalnego i ewentualnych wskazań do dalszego obrazowania.

10. Informacja dla pacjenta / wypis roboczy

Pacjent poinformowany o konieczności zgłoszenia natychmiastowego nasilenia bólu, duszności, omdlenia, spadku diurezy, narastającej gorączki, żółtaczki lub uporczywych wymiotów. Dalsze leczenie i decyzja o wypisie zależą od obrazu klinicznego, wyników badań i oceny lekarza prowadzącego.

Lekarz prowadzący	Podpis i pieczęć	Data
.....		13.06.2026

Dokument wygenerowany jako szybki wzór do nauki/ćwiczeń. W prawdziwej dokumentacji należy użyć rzeczywistych danych, wyników badań, dat, podpisów oraz procedur placówki.